SENTENÇA COM FORÇA DE MANDADO

Vistos, etc.

Trata-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA**, proposta por **LUCAS SOARES URIAS NOVAIS** em face de **SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE**, todos devidamente qualificados, alegando, em síntese, que:

O autor é beneficiário de plano de saúde administrado pela ré, encontrando-se em situação de adimplência. Foi diagnosticado com **sarcoma sinovial metastático** (câncer - neoplasia de retoabdominal) no ano de **2017**, tendo sido submetido a cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Apesar dos referidos tratamentos, a doença evoluiu, estando o autor atualmente internado no **Real Hospital Português**, necessitando de múltiplas transfusões de sangue, o que inclusive motivou mobilização social por doação de sangue.

Sustenta o autor que possui grave quadro de **plaquetopenia** e refratariedade à transfusão de concentrados de plaquetas, tendo o hematologista **Anderson Araújo (CRM/PE 4571)** prescrito tratamento urgente com o medicamento **N-Plate na dose de 0,3**

mcg/kg para "evitar hemorragias graves e risco de morte". Tal medicação foi expressamente requerida no dia **01/04/2025**, sendo, todavia, negada pela seguradora demandada.

Destaca ainda que, enquanto a medicação indicada não é disponibilizada pela ré, teve que adquirir onerosa medicação similar indicada pela equipe médica no valor de **R$ 4.529,00** (quatro mil quinhentos e vinte e nove reais), a qual, contudo, não é tão eficaz quanto a requisitada à demandada, conforme comprovado por nota fiscal anexada.

Em face do exposto, requer o integral acolhimento da pretensão inicial para:

> i) **CONCEDER** tutela provisória de urgência antecipada para determinar que a seguradora ré seja compelida a autorizar e arcar com todos os custos dos tratamentos indicados pela equipe médica, especificamente a medicação N-Plate na dose de **0,3 mcg/kg** de peso, uma vez por semana e de forma contínua, podendo a dosagem e a medicação ser alteradas mediante prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de **R$ 30.000,00**;
>
> ii) No mérito, **CONFIRMAR** a tutela de urgência, reconhecendo a responsabilidade da ré de custear todas as despesas inerentes aos tratamentos requeridos;
>
> iii) **CONDENAR** a ré ao reembolso do valor de **R$ 4.529,00** despendido na aquisição de medicamento similar, conforme nota fiscal anexada;
>
> iv) **CONDENAR** a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de **R$ 10.000,00**.

O pedido de tutela provisória de urgência foi **deferido** no ID 201162672, com a seguinte redação:

> "Ante o exposto, **DEFIRO** o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE autorize e custeie o fornecimento do medicamento N-Plate na dose de 0,3 mcg/kg de peso 01 x por semana e de forma contínua ao autor LUCAS SOARES URIAS NOVAIS, conforme prescrição médica, podendo a dosagem e a medicação serem alteradas mediante nova prescrição médica, tendo em vista o grave quadro de saúde do paciente e o risco iminente à sua vida.

Intime-se também, por MANDADO e com urgência, **o Real Hospital Português** para ciência desta decisão, **a fim de que adote as providências necessárias para o imediato fornecimento e administração do medicamento ao paciente em comum acordo com o médico assistente**, considerando seu estado crítico e o risco iminente à sua vida. Esclareça-se à instituição hospitalar que fica resguardado seu direito ao integral ressarcimento dos custos com o medicamento, sendo certo que, **em caso de recusa ou mora da operadora de saúde em liquidar as despesas correspondentes, este juízo promoverá, mediante requerimento do nosocômio, a imediata constrição de ativos financeiros da demandada via SISBAJUD em montante suficiente para saldar os valores despendidos com o tratamento ora determinado**.

Determino, ainda, que a presente decisão seja comunicada ao Hospital Português e à Sulamérica por **Oficial de Justiça plantonista**, considerando a excepcionalidade e urgência do caso, inclusive em finais de semana e feriados, se necessário."

Sul America Companhia de Seguro Saude apresentou contestação no ID 203917726, em que, preliminarmente, aduz:

> a) **Perda do objeto da ação** – cumprimento da liminar – extinção sem resolução do mérito, alegando que a pretensão perseguida pela parte autora foi totalmente satisfeita, ou seja, seu tratamento devidamente autorizado pela Seguradora, restando ausente o interesse de agir.

No mérito, afirma:

> a) **Inexistência de previsão de cobertura** para o fornecimento da medicação "N-Plate" solicitada pelo promovente, argumentando que se trata de tratamento **off label**, caracterizando uso experimental do fármaco para função diversa de sua bula, conforme disposto no art. 10, I, da Lei 9.656/98 e art. 17, parágrafo único, "c" da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS;
>
> b) **Inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98** ao contrato celebrado entre as partes, sustentando que o plano da segurada foi celebrado em **1991**, anterior à legislação dos

planos de saúde, não se aplicando a legislação vigente, mas sim seu contrato e as regras existentes na época da celebração;

c) **Ausência de ato ilícito** e inexistência de danos morais e materiais, argumentando que a negativa foi devida e que se trata de meros aborrecimentos do cotidiano, não configurando dano moral indenizável;

d) **Equilíbrio econômico e financeiro dos contratos**, sustentando que a inclusão de procedimentos não previstos contratualmente alteraria substancialmente os custos e sinistralidades dos contratos, rompendo o princípio do equilíbrio econômico-financeiro;

e) **Exorbitância da verba indenizatória** pleiteada, argumentando que os valores requeridos pela parte promovente se mostram demasiadamente exorbitantes e capazes de causar enriquecimento ilícito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que basta relatar.

Decido.

1. Do julgamento antecipado da lide.

O feito comporta julgamento antecipado, na forma do Art.355, I, do Diploma de Ritos. É que, compulsando os elementos produzidos pelas partes, se infere desnecessária a dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental apresentada. Eventual produção de prova oral ou pericial não terá o condão de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde.

Encontra-se pacificado na doutrina e na jurisprudência que o julgador, visualizando nos autos elementos suficientes para a apreciação das questões postas pelas partes, pode dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo, e julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa (Theotônio Negrão. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 31ª Edição. São Paulo: Saraiva, p. 397).

Nessa diretiva, Cândido Rangel Dinamarco é preciso ao pontuar: “a razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do

Art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento" (Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III. São Paulo: Malheiros, p.555).

Na mesma linha de raciocínio, o STF firmou entendimento de que "a necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (STF - RE 101171, Relator Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984, p.20990). Para a Corte, "o propósito de produção de provas não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado (STF -RE 96725/RS, Rel. Min. Rafael Mayer).

A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo caminho:

> AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, **não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção**. Desse modo, não há incompatibilidade entre o Art. 400 do CPC, que estabelece ser, via de regra, admissível a prova testemunhal, e o Art. 131 do CPC, que garante ao juiz o poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010).
>
> PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA POSTULADA.

> REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - **Sendo o magistrado destinatário final das provas produzidas, cumpre-lhe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias (CPC, Art.130, parte final).2- A mera alegação de haver o juízo sentenciante julgado antecipadamente a lide, com prejuízo da produção das provas anteriormente requeridas, não implica, por si só, em cerceamento de defesa**. 3- Indagação acerca da imprescindibilidade da prova postulada que suscita reexame de elementos fático-probatórios da causa (Súmula nº7). Precedentes do STJ. 4- Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no Ag 1351403/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe29/06/2011).

Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. (STJ. REsp nº2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, QUARTA TURMA). No mesmo sentido: RSTJ 102/500 e RT 782/302.

2. Preliminar

2.1 Da Perda do Objeto

A ré sustenta preliminar de perda do objeto da ação, alegando que a pretensão perseguida pela parte autora foi totalmente satisfeita com o cumprimento da liminar concedida, restando ausente o interesse de agir para prosseguimento da demanda.

A preliminar não merece acolhimento.

> O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que **"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"** (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

O fundamento da jurisprudência consolidada reside na necessidade de definição judicial sobre a existência efetiva do direito material alegado. A tutela provisória de urgência possui natureza cautelar e satisfativa provisória, não constituindo julgamento definitivo do mérito. Sua concessão baseia-se em cognição sumária, fundada na verossimilhança das alegações e no perigo de dano, não implicando reconhecimento definitivo do direito pleiteado.

No caso em exame, embora a ré tenha cumprido a determinação liminar, fornecendo o medicamento N-Plate ao autor, permanece controvertida a questão de fundo acerca da obrigatoriedade contratual e legal de cobertura do tratamento prescrito. A controvérsia envolve temas como: (i) a natureza do uso off-label do medicamento; (ii) a aplicabilidade da Lei nº 9.656/98 ao contrato celebrado em 1991; (iii) a abusividade ou não da negativa inicial; e (iv) a existência de danos morais e materiais decorrentes da conduta da operadora.

Tais questões demandam pronunciamento judicial definitivo, não sendo suficiente o mero cumprimento da liminar para extinguir o interesse processual. O autor possui interesse jurídico na obtenção de provimento definitivo que: (a) confirme sua pretensão de cobertura futura para tratamentos similares; (b) declare a abusividade da negativa inicial; (c) condene a ré ao ressarcimento de valores despendidos; e (d) fixe indenização por danos morais.

Ademais, a ausência de julgamento de mérito implicaria insegurança jurídica, pois a ré poderia, em situações futuras similares, negar novamente cobertura com base nos mesmos fundamentos ora alegados, forçando o autor a renovar constantemente pedidos liminares.

Por essas razões, **rejeito a preliminar** de perda do objeto da ação, determinando o prosseguimento da demanda para julgamento do mérito, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

3. Mérito

3.1 Do Dever de Cobertura

Consoante emerge dos elementos coligidos, o relacionamento obrigacional estabelecido entre as partes se iniciara antes da vigência da lei dos planos de saúde e, sem notícia de sua adaptação, vige até os dias atuais. Destarte, diante do fato de que o contrato é antigo e não houve adaptação à Lei 9.656/98, deve, de regra, prevalecer o livremente pactuado.

Como cediço, o ato jurídico perfeito é resguardado como inerente à irretroatividade legislativa pelo próprio legislador constitucional. Assim, em se tratando de contrato antigo e não adaptado, não está sujeito à incidência da lei dos planos de saúde, pois lhe é posterior.

Ressalte-se que, em julgamento recente, datado de fevereiro de 2018, o Plenário do **Supremo Tribunal Federal** julgara parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN nº 1931/DF, que questionava a Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), considerando válida a maioria dos dispositivos questionados, entendendo, contudo, que **os contratos celebrados antes da vigência da norma não podem ser atingidos pela regulamentação dos planos de saúde que encartara**. Em tal abordagem, os artigos 10, § 2º, e 35-E da Lei nº 9.656/1998 e o artigo 2º da MP 2.177-44/2001, foram declarados inconstitucionais. Ressalve-se que o acórdão fora publicado em 1º de agosto de 2018[1].

> "Cumpre ressaltar, destarte, o que dispunham os artigos declarados inconstitucionais, adiante transcritos, para compreensão da matéria em exame:
>
> "Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no Art. 12 desta Lei, exceto:
>
> (...) § 2 As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o § 1º, do Art. 10 desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro

> de 1999, o plano referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores."
>
> (...)
>
> "Art. 35-E. **A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que**:
>
> I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;
>
> III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do Art. 1º desta Lei por parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do Art. 13 desta Lei;
>
> IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico, cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente.
>
> § 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:
>
> I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo único do Art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que, aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último ano da faixa etária considerada;
>
> II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior (...)." (grifos nossos)

Frisou o Supremo Tribunal Federal, em síntese, que os dispositivos reputados desconformes previam a incidência de novas regras relativas aos planos de saúde aos contratos celebrados anteriormente à vigência da Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), criando parâmetros completamente distintos daqueles que foram objeto da contratação, violando, com isso, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, estabelecidos no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, devendo-se observar, ademais, o princípio da segurança jurídica,

que não autoriza o afastamento de ato jurídico perfeito mediante aplicação de lei nova. De relevo anotar que o eminente relator da ação declaratória de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal, deixou acentuado, ao final da argumentação que, à guisa de tutelar o direito do consumidor, o legislador exorbitara o autorizado pela Constituição Federal, substituindo a vontade dos contratantes, incorrendo em inconstitucionalidade, *verbis*:

> "(...) **Os dispositivos em análise preveem a incidência das novas regras relativas aos planos de saúde em contratos celebrados anteriormente à vigência do diploma. A norma destoa do Texto Maior. A vida democrática pressupõe segurança jurídica, e esta não se coaduna com o afastamento de ato jurídico perfeito e acabado mediante aplicação de lei nova. É o que decorre do inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal**:
>
> Art. 5º [...] XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
>
> É impróprio inserir nas relações contratuais avençadas em regime legal específico novas disposições, sequer previstas pelas partes quando da manifestação de vontade.
>
> (...)
>
> **A toda evidência, o legislador, com o intuito de potencializar a proteção do consumidor, extrapolou as balizas da Carta Federal, pretendendo substituir-se à vontade dos contratantes. Salta aos olhos a inconstitucionalidade. Ante o quadro, reafirmo o entendimento externado no exame do pedido liminar, para julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 10, § 2º, e 35-E da Lei nº 9.656/1998, bem assim do artigo 2º da Medida Provisória nº2.177-44/2001**."

Sob essas premissas, celebrado o contrato que enlaça as litigantes antes da entrada em vigor da Lei 9.656/98, ressaltando-se o fato de que o contrato é antigo e não há notícia de sua adaptação à lei dos planos de saúde, deve-se observar o pactuado originalmente.

A hipótese de o contrato ter sido celebrado antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, no entanto, a luz do que sufragado pelo E. STJ, não constitui razão suficiente para afastar a sua incidência. Isso porque:

> AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CDC. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. **RENOVAÇÃO DO CONTRATO NA VIGÊNCIA DO CDC. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA**. (...) 2.- **Embora o CDC não retroaja para alcançar efeitos presentes e futuros de contratos celebrados anteriormente a sua vigência, a legislação consumerista regula os efeitos presentes de contratos de trato sucessivo e que, por isso, foram renovados já no período de sua vigência.** (...) (AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 323.519/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 18/09/2012)

Não sem razão, quando da edição da Súmula nº 608, o colendo STJ estabeleceu, sem ressalvas cronológicas, que "**aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão**" (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.04.2018, DJe17.04.2018; na mesma oportunidade, cancelou-se a Súmula nº 469).

Estabelecida a premissa de que a análise da controvérsia deverá observar o regramento estabelecido no contrato e as disposições do código consumerista, verifica-se que a controvérsia apresentada no feito gravita em torno da obrigatoriedade de cobertura do medicamento N-Plate para tratamento de plaquetopenia decorrente de sarcoma sinovial metastático e a caracterização de eventual abusividade na negativa de fornecimento pela operadora.

O documento de ID 201069609 indica que a negativa administrativa decorreu de suposto uso off label do medicamento, senão vejamos:

> "Nplate 210 mg em 11/04; 18/04; 25/04 E 02/05/2025 - **não há indicação em bula para uso nesta indicação específica**."

Contudo, verifico que não foi apresentada pela ré cláusula específica que fundamentasse a negativa de cobertura, ônus que lhe incumbia.

Da análise contratual, ainda que se admita a possibilidade do contrato de plano de saúde conter cláusulas que limitem direitos do consumidor, mostra-se abusiva a interpretação contratual restritiva no sentido de afastar a cobertura de medicamento necessário ao tratamento antineoplásico do consumidor.

Tal conclusão mostra-se ainda mais inafastável quando se verifica que o medicamento N-Plate foi prescrito como parte essencial do tratamento oncológico do autor, portador de sarcoma sinovial metastático, para controle de plaquetopenia grave com risco iminente de hemorragias e morte.

Nesse sentido, importa invocar a aplicação do Art. 47, do CDC, segundo o qual, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Ocorre, no entanto, que a exclusão da cobertura do medicamento indicado pelo médico assistente para o tratamento da enfermidade significaria negar a própria essência do tratamento antineoplásico, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a cobertura de medicamentos em uso off label quando prescritos por profissional médico e registrados na ANVISA:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. **PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE SER INDICAÇÃO DE TRATAMENTO OFF-LABEL. SÚMULA 7/STJ . FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO OFF-LABEL. CABIMENTO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO**. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O aresto estadual entendeu que a indicação dos remédios receitados configurou uso off-label. Aplicação da Súmula 7/STJ . 2. **O fato de os fármacos em questão - Avastin (Bevacizumabe) e Temodal**

> **(Temozolomida) - configurarem uso off-label, em nada afeta o dever de fornecimento, pois "quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo**" (REsp n. 1 .769.557/CE, Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1 .712.163/SP e o REsp 1.726.563/SP (Rel . Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/11/2018), representativos de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n. 990) segundo a qual "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Porém, no caso concreto, não se trata de medicamento não registrado na autarquia, e sim de uso e indicação off-label, conforme consta no acórdão recorrido. Destarte, é aplicável ao caso o enunciado da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1677613 SP 2020/0057909-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2020)

Importa distinguir que o uso off label não se confunde com o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA. No caso concreto, o medicamento N-Plate possui registro sanitário regular (Registro ANVISA nº 1024400030015), de modo que a aplicação do Tema 990/STJ se mostra incabível.

Inequívoco, portanto, o direito da parte autora ao tratamento que lhe foi sonegado.

A recusa manifestada pela ré afrontou a própria essência do contrato celebrado com o autor bem como a sua função social, na medida em que lhe subtraiu a possibilidade de ser tratado do mal que o acomete e que coloca em risco a sua vida. O contrato em questão é cativo de longa duração, e o autor possuía a justa expectativa de que, no momento em

que mais necessitava dos serviços prestados pela seguradora ré, em razão da sua grave patologia oncológica, não lhe seriam opostos óbices ao tratamento de que necessitava.

Em casos análogos, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Pernambuco tem reconhecido a inequivocidade do direito do consumidor segurado:

> APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SPRAVATO 28 MG. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE DE ALTO RISCO. CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE PROCEDMENTOS DA ANS. TRATAMENTO QUE DEVE SER REALIZADO DENTRO DA REDE CREDENCIA, SOB PENA DO REEMBOLSO SER EFETIVADO EM OBSERVÂNCIA AOS LIMITES ESTABELECIDOS NO CONTRATO, NO CASO DO SEGURADO OPTAR PELA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA, SEM PROCEDER À COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA QUE SE REVELA RAZOÁVEL NA HIPÓTESE. 1. O plano de saúde não pode se imiscuir na função médica acerca da indicação do tratamento mais adequado ao restabelecimento da saúde do paciente 2. Independentemente do medicamento solicitado ser de uso ambulatorial, há que se observar tratar-se de fármaco devidamente registrado na ANVISA, já havendo o segurado se submetido a diversos tratamentos anteriores sem que tivesse obtido resposta terapêutica, acarretando um alto risco à vida do autor, ante o concreto planejamento suicida, atestado no laudo médico colacionado aos autos. (TJ-PE–AI: 0012128042022817900O, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGÍNIO, Data de Julgamento: 09/09/2022, Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins).

3.2 Dos Danos Materiais

O pedido de ressarcimento dos valores despendidos pelo autor merece integral acolhimento.

A prova do dano material encontra-se inequivocamente demonstrada pela nota fiscal constante do ID 201069613, que comprova a aquisição do medicamento Revolade 50mg no valor de **R$ 4.529,00** (quatro mil quinhentos e vinte e nove reais), em 10/04/2025.

A aquisição decorreu diretamente da negativa indevida da ré em fornecer o medicamento N-Plate prescrito pelo médico assistente, obrigando o autor, em estado crítico de saúde e risco iminente de vida, a adquirir medicação similar por conta própria para não interromper o tratamento essencial.

Estabelecido o nexo causal entre a conduta ilícita da ré e o prejuízo material suportado pelo autor, impõe-se a condenação ao ressarcimento integral dos valores comprovadamente despendidos.

3.3. Sobre Os Danos Morais Alegados Pela Demandante.

Assiste razão à autora quando pugna por verba indenitária compensatória em razão dos danos morais resultantes de conduta da demandada.

O descumprimento contratual, em regra, não gera dano moral. Entretanto, o agravamento da aflição psicológica do usuário de plano de saúde, que, para além da sua específica condição debilitada se vê abandonado e desguarnecido da proteção contratualmente acertada, inegavelmente configura hipótese de ofensa ao seu patrimônio imaterial.

Como já assinalado, o caso é de inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, respondendo a ré de forma objetiva perante o consumidor, nos termos do artigo 14 do código consumerista.

É consabido que a Política Nacional das Relações de Consumo objetiva atender às necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, a sua saúde e a sua segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia a elas inerentes, nos termos do Art. 4º, *caput* do CDC. Os princípios inerentes a essa política protecionista

estão insculpidos nos diversos incisos do Art. 4º do CDC. Dentre eles evidencio: (i) o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (Art. 4º, I, do CDC); (ii) a harmonização dos sujeitos das relações de consumo, sempre com base na boa-fé e no equilíbrio (Art. 4º, III, do CDC); (iii) a informação adequada, com vistas à melhoria do mercado de consumo (Art. 4º, IV, do CDC) e (iv) a coibição e à repressão eficiente de todos os abusos nele praticados (Art. 4º, VI, do CDC).

Nessa senda, associado ao exercício da livre iniciativa fundada em valores sociais (arts. 1º, IV; 170, *caput* e V; e 173, § 4º, da Constituição da República), é dever irrenunciável da demandada ser transparente e agir de boa-fé (objetiva), assegurando o equilíbrio nas relações de consumo com o atendimento das necessidades dos seus contratantes.

A proteção à saúde como direito básico dos consumidores é um dos sustentáculos da dignidade da pessoa humana constitucionalmente assegurada e dirige-se à realização dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, entre eles, a liberdade, a justiça e a solidariedade.

Nesse contexto, quando a seguradora ré se nega a fornecer ou a autorizar, procedimentos, medicamentos, exames diagnósticos e materiais demandados pela equipe médica no período em que o segurado se encontra fragilizado física e psiquicamente em razão do adoecimento afigura-se como prática abusiva, fundada no abuso de poder econômico, em detrimento da defesa e do respeito ao consumidor.

No caso em tela incide a teoria do risco do empreendimento que reclama responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do CDC, evidenciada pela inobservância dos deveres de lealdade, transparência e boa-fé que devem nortear as relações de consumo, no cumprimento do contrato, de modo a acarretar transtornos capazes de ensejar ofensa ao patrimônio subjetivo do segurado.

A indevida negativa de autorização de procedimento, sem causa fática ou legal que a legitime, constitui abuso de direito que se amolda ao enunciado do artigo 186 do Código Civil e por isso é ato ilícito, ensejador

de reparação através dos critérios compensatórios e sancionatórios, visando à recomposição do patrimônio moral violado, com base nos efeitos do ato lesivo, de modo a proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido.

A jurisprudência, com a qual me filio, em situações análogas não tem trilhado caminho diverso:

> DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 608 DO STJ. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONTRATUAIS CIVIS. **NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS THACOSIL E COLA BIOLÓGICA NECESSÁRIOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO**. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Tratando-se de entidade caracterizada pela autogestão e sem fins lucrativos, limitada a funcionários do Banco do Brasil S/A e seus parentes, ou seja, sem atuação no mercado de consumo, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 608.2. Todavia, ainda que afastada a aplicação do Código Consumerista, é fato que os princípios contratuais previstos na legislação civilista devem ser observados, notadamente a função social dos contratos (Art. 421) e os princípios da probidade e boa-fé objetiva (Art. 422), além da interpretação mais favorável ao aderente, em casos de contratos de adesão (Art. 423).3. Analisando as razões trazidas aos autos, entende este Colegiado que a tese defendida pelo plano de saúde apelante não é suficiente para justificar a não viabilização imediata do procedimento terapêutico requisitado, pois, considerando que a disponibilização de tratamentos médico-hospitalares necessários ao restabelecimento da saúde do segurado constitui a própria essência do contrato de seguro saúde, qualquer atitude tomada pela operadora de plano de saúde que obstaculize a cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente, se mostra, a toda evidência, contrária à própria natureza do contrato, ameaçando seu objeto e o equilíbrio contratual, sendo, por isso, ilícita. 4. É obrigação da seguradora de saúde autorizar o serviço de saúde da maneira como requerido pelo médico assistente, por ser ele detentor de capacidade

técnica para justificar a sua indicação e responsável por ponderar se o tratamento é capaz de influir na cura da paciente, podendo apenas o plano de saúde eleger que doenças estarão ou não abrangidas pela sua cobertura. Precedentes. 5. A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no seu espírito. Casos de negativa de cobertura contratual por parte da operadora de saúde não pode ser visto como mero inadimplemento ou discussão contratual, caracterizando dano moral. Precedentes jurisprudenciais. 6. Constata-se que a parte ré, ora apelante, não trouxe informações capazes de rechaçar cabalmente as alegações do ator/apelado, não se desincumbindo de seu ônus probatório previsto pelo Art. 373, II, do CPC e sendo assim o reembolso integral das despesas contraídas pelo recorrido com o material cirúrgico deve ser deferido, tal como entendeu o juiz a quo não merecendo reparo sua decisão no tocante aos danos materiais sofridos.7. Em sessão, deliberando-se acerca do quantum indenizatório e tomando por base os pressupostos de razoabilidade e proporcionalidade que devem permear a fixação da indenização por danos morais, considerou o Colegiado como razoável a redução do valor arbitrado em sentença para R$ 7.000,00 (sete mil reais). 8. Recurso parcialmente provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE, Apelação Cível 0000092-19.2013.8.17.1280 (545551-4), Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior. Data do Julgamento: 05/02/2020). (Destaquei)

PLANO DE SAÚDE – SEGURADO – CONTRATO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – DESCONSIDERAÇÃO – Os contratos celebrados para assistência à saúde, se identificam como de prestação de serviço e devem obediência às regras do Código de Defesa do Consumidor no que respeita às cláusulas ditas abusivas, como o são aquelas que colocam o usuário do serviço em desvantagem exagerada em relação àquele que os presta; a inadimplência de sessenta dias que autoriza a suspensão do contrato é aquela é a contínua e não a que soma pequenos dias de atrasos alternados ocorridos ao longo do pacto. **Constatado que o segurado estava com suas prestações atualizadas, a recusa em atendê-lo quando necessitou do serviço, é certa que lhe acarretou prejuízos de natureza moral e material, esta, quando ele teve que desembolsar recursos próprios para tratar-se de sua enfermidade**; o dano material é o que ficou, objetivamente, provado, enquanto que o dano moral, que tem natureza subjetiva, deve ser arbitrado, segundo as circunstâncias do caso,

> suas consequências, partes envolvidas, tendo sempre presente que a condenação, que reverterá em favor do ofendido, tem caráter educativo, e, por isso, há que ser arbitrada de modo a não se revelar insignificante, e, por outro lado, não deve ser tão elevada para não se converter em locupletamento (TJMA – AC 019119/2002 – (44.287/2003) – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Stélio Muniz – J. 24.04.2003). (Destaquei)

Nesse cenário, a condenação da ré a compensar os danos de ordem imaterial suportados pela parte demandante se impõe, a partir de uma estimação prudencial que leve em consideração o grau em que o prejuízo causado influiu no seu ânimo e no seu sentimento:

A intensidade da culpa, a violência, as circunstâncias em que ocorreu o evento danoso poderão informar o critério a ser adotado em tal arbitramento, árduo e delicado, porque entranhado de subjetividade. (TJRJ - 8ª C. - Ap. - Rel. Silveira Neto - j. 29.10.92 - JTJ- LEX 142/104).

A vítima de lesão de direitos de natureza não patrimonial (Constituição da República, Art. 5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP - 7º Rel. Campos Mello j. 30.10.91 RJTJESP 137/187).

A reparação, nesse panorama, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aquilatados de acordo com as peculiaridades que envolvem o pleito (STJ - RESP 200500465226 - (736968) - RJ - 4ª T. - Rel. Min. Jorge Scartezzini - DJU 01.07.2005 - p. 00559).

Dito isto, em atenção aos critérios e princípios acima elencados e consideradas as peculiaridades do caso em comento, tenho que, diante das provas documentais constantes dos autos, houve perceptível inobservância da indispensável equidade da mesma no desenvolvimento do trato contratual avençado, propiciando plenas condições à respectiva ocorrência.

Concernente às repercussões do fato danoso, tenho-os como relevantes para abalar a personalidade da autora, principalmente por ocorrer no momento em que esta necessitava do devido respaldo econômico e de tranquilidade para se recuperar.

Destarte, consideradas as peculiaridades do caso em questão e tendo em vista os princípios de moderação e razoabilidade, entendo ser justo e necessário fixar o importe compensatório pertinente em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo tal imposição plenamente justificável para que de um lado se tenha a devida compensação pelos transtornos passados pela autora e, de outro, medida verdadeiramente pedagógica, pois destinada a de tentar evitar a reiteração da conduta perpetrada pela demandada, explicitamente prejudicial aos seus contratantes, consumidores.

4. Dispositivo

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão entabulada na exordial para, confirmando a tutela deferida, **CONDENAR** a empresa ré a:

> (i) ao **fornecimento do medicamento** N-Plate na dose de 0,3 mcg/kg de peso ao autor, na forma prescrita pelo seu médico assistente, o que deverá ser feito uma vez por semana e de forma contínua, podendo a dosagem e a medicação serem alteradas mediante nova prescrição médica, em ambiente hospitalar por profissional de saúde credenciado pelo plano;
>
> (ii) ao **reembolso** do valor de **R$ 4.529,00** (quatro mil quinhentos e vinte e nove reais) despendido pelo autor na aquisição de medicamento similar, acrescido de correção monetária pela tabela ENCOGE desde o desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação até o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, que ocorrerá após 60 (sessenta) dias de sua publicação em 01/07/2024, a partir de quando deverá incidir o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA) para fins de juros moratórios; e
>
> (iii) pagar, a título compensatório pelos danos morais impostos ao autor, o valor de **R$ 8.000,00** (oito mil reais). Tal montante deverá ser atualizado pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) a

partir desta decisão (Súmula 362, do STJ) e acrescida de juros de mora equivalentes à Taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária (IPCA), conforme determina a Lei nº 14.905/2024, a contar da citação, observando-se o disposto no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela referida lei.

Condeno a demandada a pagar custas e honorários advocatícios que ora fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 2º do CPC.

No caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios (inclusive voltados à mera rediscussão do julgado), aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º do mesmo artigo.

Interposta a apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC, que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (Art. 1.010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal.

Publique-se e intimem-se.

Certificado o trânsito, arquivem-se os autos definitivamente.

Via eletronicamente assinada servirá como expediente de comunicação processual.

Recife (PE), 27 de maio de 2025.

José Júnior Florentino dos Santos Mendonça

Juiz de Direito

[1] Disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1741189. Acesso em 07/04/2020, às 12:05.

Assinado eletronicamente por: JOSE JUNIOR FLORENTINO DOS SANTOS MENDONCA
27/05/2025 08:56:41
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 205273101

25052708564165800000199935040

IMPRIMIR GERAR PDF